4.3 Le bilan primaire

Le bilan primaire a pour but de rechercher une détresse vitale qui menace immédiatement la vie de la victime et qui nécessite la mise en œuvre rapide de gestes de secours.
Par opposition au bilan circonstanciel, il s'agit d'**un zoom sur la victime elle-même.**

Bilan primaire



A. Principe général

Après avoir réalisé la sécurité de la zone d'intervention, **le bilan primaire débute par l'observation rapide de la victime** au cours de laquelle des mesures de sauvegarde immédiates peuvent être prises.

Elle est suivie par une appréciation rapide des fonctions vitales (neurologique, respiratoire et circulatoire), qui elle-même peut entraîner d'autres mesures de sauvegarde spécifiques à la détresse. **En une dizaine de secondes on doit savoir si l'état de la victime est critique ou non.**

Le bilan primaire doit être ordonné, rigoureux et **répété dès lors qu'un changement de l'état de la victime est constaté lors de la surveillance, afin de détecter la survenue d'une détresse vitale initialement absente.**

Si tout sapeur-pompier doit savoir réaliser le bilan primaire et effectuer les actions de secours nécessaires, **en équipe le bilan primaire est effectué par le chef d'agrès,** plus expérimenté et aguerri au commandement (gestion des priorités et ordres aux équipiers).

Au cours du bilan primaire, le sapeur-pompier focalise son attention sur la victime elle-même **et doit passer par quatre étapes indispensables :**

1. **Sauvegarde immédiate :** observer la situation en focalisant son attention sur la victime pour se faire une idée générale de son état et prendre les premières mesures afin de la garder en vie **(désobstruction des voies aériennes, arrêt des hémorragies)**.
2. **Conscience :** questionner et stimuler doucement la victime pour rechercher une inconscience, sinon l'écouter pour identifier sa plainte principale.
3. **Respiration :** apprécier rapidement un arrêt respiratoire ou une détresse respiratoire évidente.
4. **Circulation :** apprécier rapidement un arrêt circulatoire ou une détresse circulatoire.

L'appréciation de la conscience, de la respiration et de la circulation entraine des **gestes de sauvegarde spécifiques :** insufflations, RCP, positions d'attente et mise sous O_2.

À l'issue de l'évaluation rapide de ces trois fonctions vitales, **le chef d'agrès peut demander en urgence l'envoi immédiat d'une équipe médicale.**

Pendant ce bilan primaire, les sapeurs-pompiers doivent anticiper les actions à venir et prévoir une éventuelle aggravation de l'état de la victime en préparant le matériel à mettre en œuvre et en envisageant les gestes à accomplir.

Le bilan primaire permet donc de traiter l'extrême urgence et d'empêcher la victime de mourir.

L'ordre des actions dépend toutefois de chaque situation.

Tant que l'urgence vitale n'est pas réglée ou que l'on n'a pas mis en œuvre toutes les ressources, on ne passe pas au bilan secondaire

A.1 Sauvegarde immédiate

L'approche et un examen rapide de la victime permettent de noter rapidement :

- **son apparence et le contexte dans lequel elle se trouve,** ce qui permet le plus souvent de savoir s'il s'agit d'une personne consciente ou apparemment inconsciente, blessée ou victime d'un malaise ou d'une maladie ;
- **l'existence d'une détresse vitale évidente** comme :
  - une **obstruction complète ou quasi complète des voies aériennes :** dans ce cas, il convient sans délai de mettre en œuvre les manœuvres de désobstruction adaptées à l'âge de la victime (cf. chapitre 6) ;
  - une **hémorragie :** devant une hémorragie externe, il convient de réaliser immédiatement une technique d'arrêt du saignement (cf. chapitre 7) ;
- **une suspicion de traumatisme du rachis dans le cas d'une victime blessée.** Dans ce cas, **un maintien de la tête est effectué immédiatement et systématiquement** pour tout blessé, conscient ou inconscient. Il est précédé si nécessaire, par une remise de la tête en position neutre. En cas de doute, on considère toujours que la personne peut présenter un traumatisme (cf. fiche technique 16.1).

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

Ce **maintien de la tête n'est pas relâché** sauf :

- après une immobilisation complète de la victime ;
- si des manœuvres de réanimation doivent être entreprises ;
- si on a rapidement la certitude qu'il n'y a eu ni chute ni traumatisme crânien ;

- **sa position** qui va permettre d'anticiper les actions à venir comme un retournement, une mise en PLS… ;
- **son âge approximatif et son sexe.**

Dans le cas particulier où la victime présente les caractéristiques d'un décès certain (cf. chapitre 1), aucun geste de secours n'est entrepris.

A.2 Conscience

L'appréciation de la conscience est réalisée en quelques secondes **en posant une question simple** à la victime **et en** lui **demandant d'exécuter un ordre simple** adapté à son état : *« Comment ça va ? Ouvrez les yeux, serrez-moi la main, de quoi vous plaignez-vous ? »*.

Si la victime ne répond pas et ne réagit pas, elle est inconsciente (coma). Dans ce cas, **le matériel de réanimation doit être immédiatement préparé et mis en œuvre,** parallèlement à la poursuite du bilan primaire et aux gestes d'urgence à pratiquer.

Si elle répond ou réagit, elle est consciente et les réponses qu'elle va donner permettront éventuellement **d'identifier sa plainte principale.**

En cas de suspicion de traumatisme, aucun mouvement important ne doit lui être demandé, il faut donc lui faire serrer les mains sans mobiliser les bras.

Ce premier contact avec la victime permet aussi lorsqu'elle est consciente, d'évaluer un certain nombre d'autres paramètres du bilan secondaire. En touchant les mains de la victime, on peut apprécier sa température et la moiteur de sa peau.

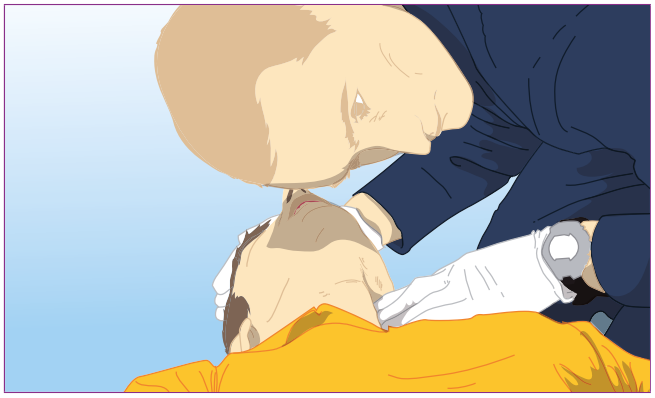
A.3 Respiration ET A.4 Circulation

Premier cas : victime inconsciente

- **Assurer la libération de ses voies aériennes** (cf. fiches techniques 13.1, 13.2 et 13.3)
- **Rechercher sa respiration sur 10 secondes au maximum** (cf. fiche technique 14.1).
- Rechercher la circulation simultanément à la respiration **par une recherche du pouls carotidien sur 10 secondes au maximum (**cf. fiche technique 15.1**).**

En effet, après un arrêt de la circulation, la respiration peut sembler normale quelques dizaines de secondes puis se transformer en gasps avant de disparaître. Il est donc important de détecter rapidement l'arrêt circulatoire.

La prise simultanée du pouls et de la ventilation



Si la prise de pouls carotidien n'est pas possible (emphysème sous-cutané géant, hématome ou œdème au niveau du cou, radiothérapie…), elle peut se faire au niveau fémoral.

Second cas : victime consciente

- Elle respire. Néanmoins, une appréciation visuelle et auditive rapide de sa respiration permet de mettre en évidence une éventuelle détresse.
- Un premier contact permet aussi d'évaluer un certain nombre de paramètres normalement appréciés lors du bilan secondaire. **La palpation rapide du pouls radial** permet sans le chiffrer, d'apprécier globalement sa fréquence (à peu près normale, rapide ou lente), son rythme (régulier ou non) et sa qualité (bien ou mal perçu). **Seule une détresse circulatoire évidente (pouls radial non perçu) peut ainsi être appréhendée lors du bilan primaire.**

À l'issue du bilan primaire, le chef d'agrès peut avoir mis en évidence un trouble ou une détresse particuliers.

Il donne alors ses priorités à ses équipiers pour la suite du bilan (éléments du bilan secondaire) :

- **devant une détresse respiratoire avec administration d'O_2, la mesure de la saturation doit être prioritaire (simultanée à la mise sous O_2 ou différée de quelques secondes). Le résultat de la mesure est alors la SpO_2 en air ambiant car le surplus d'O_2 n'a pas eu le temps d'être distribué ;**
- **devant une détresse circulatoire, la mesure de la pression artérielle doit être prioritaire.**

En touchant les mains de la victime, on peut apprécier sa température et la moiteur de sa peau. Il s'agit aussi d'un contact physique indiquant à la victime qu'on la prend en compte.

Conclusion

Selon l'état de la victime, Le bilan primaire détecte cinq situations principales :

- **la victime est consciente ;**
- **la victime est inconsciente, respire et :**
  - **ne présente pas de signe de traumatisme ;**
  - **présente des signes de traumatisme ;**
- **la victime est inconsciente et ne respire pas ;**
- **la victime est inconsciente, ne respire pas et ne présente pas de signe de circulation.**

Ce bilan primaire, ainsi que les actions qui en découlent doivent **être réalisés de manière systématique et méthodique.**

B. Les différents types de bilans primaires et les actions à mener

B.1 Le bilan primaire de la victime consciente

Étape 1 : sauvegarde immédiate

L'approche de la victime ne diffère pas du cas général.

Toute suspicion de traumatisme crânien ou rachidien doit entraîner un maintien de la tête quelle que soit la position de la victime.

Étape 2 : conscience

1. **Apprécier la conscience :** une victime qui réagit ou répond aux ordres simples et adaptés à son état est consciente.
2. **Maintenir la victime dans sa position :** en cas de traumatisme, la victime consciente allongée sur le ventre n'est pas retournée immédiatement, mais seulement lors de son immobilisation sur un plan dur si un premier examen lésionnel rapide le permet.
3. **Identifier la plainte principale :** les questions posées vont permettre aux sapeurs-pompiers d'identifier la plainte principale.

Ces questions permettent également de recueillir des informations pour le bilan secondaire en mettant en évidence des troubles neurologiques.

Par exemple :

- la qualité de la réponse verbale ;
- l'orientation dans le temps et dans l'espace ;
- la qualité de la réponse sensitive et motrice ;
- une éventuelle perte de connaissance initiale.

Étape 3 : respiration

1. **Faciliter la respiration :** desserrer ou dégrafer rapidement tout ce qui peut gêner la respiration et si nécessaire, aider la victime à recracher tout corps étranger présent dans la cavité buccale.
2. **Étudier la respiration.** Ce bref examen permet d'anticiper le bilan secondaire en notant :
   - des difficultés évidentes pour répondre aux questions en enchaînant des phrases complètes (essoufflement) ;
   - d'autres signes de détresse respiratoire, identifiables lors de ce premier contact : bruits, sueurs, cyanose, tirage au niveau des muscles du cou ;
   - une fréquence respiratoire très rapide, très lente ou irrégulière.
3. **Mettre la victime en position assise en présence d'une détresse respiratoire :** une victime consciente présentant des signes de détresse respiratoire doit immédiatement être mise en position assise, si elle n'a pas déjà adopté cette position d'elle-même et si cela est possible (absence de suspicion de fracture du bassin ou du rachis).

4. **Administrer de l'oxygène par inhalation** si nécessaire (cf. fiche technique 20.1).

Étape 4 : circulation

1. **Étudier la circulation :** Ce bref examen permet de : **détecter une détresse circulatoire par la recherche du pouls radial.** Lorsqu'il est absent on vérifie alors le pouls carotidien ;
2. **Allonger immédiatement une victime présentant une détresse circulatoire évidente** (pouls radial non perçu), **en l'absence de détresse respiratoire.** Cette position de repos améliore la circulation notamment au niveau du cerveau.
3. **Administrer de l'oxygène par inhalation** :
   - si pas de détresse circulatoire = O_2 si nécessaire ;
   - si détresse circulatoire = O_2 systématique.

Dans le cas d'une victime consciente, les étapes 2, 3 et 4 sont quasiment réalisées simultanément et montrent l'importance de la première prise de contact du chef d'agrès avec sa victime car elle conditionne bien souvent la suite de l'intervention.

L'appréciation de la qualité de la respiration et de la circulation ne consiste pas à les évaluer précisément mais uniquement à rechercher les signes d'une détresse évidente qui sont souvent visibles lors de l'interrogatoire de la victime.

Cette première approche de la victime permet aussi de détecter les signes communs à de nombreuses détresses : **pâleur et sueurs**. La persistance de ces signes constitue une alerte même si la plainte principale n'est pas précise ou parait banale (fatigue par exemple).

Cela montre l'importance d'un contact physique avec les mains de la victime et l'observation de son visage car ils sont riches d'enseignements.

Dans le cas d'une victime consciente sans détresse évidente, le bilan secondaire permet alors d'évaluer de manière plus approfondie son état et de demander éventuellement une équipe médicale.

Installer la victime en position assise et administrer de l'O_2 par inhalation



B.2 Le bilan primaire de la victime malade inconsciente qui respire sans notion de traumatisme

Une victime qui est immobile, qui ne répond pas aux questions et ne réagit pas à un ordre simple est inconsciente (coma).

Il faut préserver et améliorer sa respiration en assurant rapidement la liberté des voies aériennes, geste indispensable pour permettre le libre passage de l'air surtout si elle est allongée sur le dos. Simultanément, une administration d'oxygène par inhalation est réalisée.

Étape 1 : sauvegarde immédiate

L'approche de la victime ne diffère pas du principe général. Son apparence laisse à penser qu'elle est inconsciente à cause d'un malaise ou d'une maladie, sans aucune notion de traumatisme.

Étape 2 : conscience

1. **Apprécier la conscience :** la victime ne répond pas aux questions et ne réagit pas aux ordres simples : elle est inconsciente (coma).

Étape 3 : respiration ET Étape 4 : circulation simultanément

1. **Retourner la victime si elle est sur le ventre** (cf. fiche technique 11.2) afin :
   - de rechercher avec certitude les signes de respiration ;
   - d'assurer la liberté des voies aériennes ;
   - de réaliser les gestes d'urgence nécessaires.
2. **Libérer les voies aériennes** (cf. fiche technique 13.1).
3. **Apprécier la respiration et la circulation simultanément sur 10 secondes** (cf. fiche technique 14.1) et (cf. fiche technique 15.1). Si le thorax ou le haut de l'abdomen se soulèvent, que d'éventuels bruits ou son souffle sont perçus, la victime respire.

   Il ne faut pas confondre les gasps avec des mouvements respiratoires. En cas de gasps ou de respiration anormale, on considère la victime en arrêt respiratoire, donc en arrêt cardiaque.

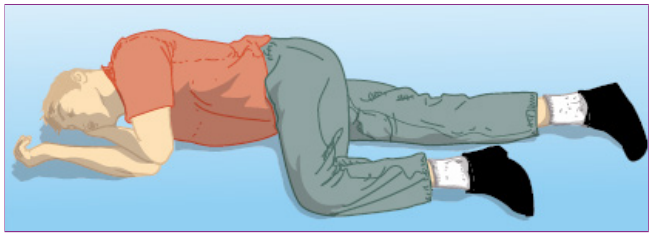
   En cas de pouls carotidien mal perçu ou douteux, on considère la victime en arrêt cardiaque. L'idée de demander à un équipier de vérifier le pouls carotidien doit faire conclure qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque.

   Lorsqu'une respiration et une circulation efficaces sont détectées, la recherche doit s'interrompre immédiatement pour ne pas retarder la suite de la prise en charge.

Rechercher la présence du pouls radial pour détecter une détresse circulatoire en plus de la détresse neurologique.

4 **Placer immédiatement la victime en position latérale de sécurité (PLS)** (cf. fiche technique 17.1). Dans le cas d'une victime malade, la mise en PLS peut être réalisée seul (cf. fiche technique 17.2).

Placer la victime en PLS



5 **Administrer de l'oxygène par inhalation :** (cf. fiche technique 20.1).

6 **Demander une équipe médicale en précisant le contexte :** immédiatement après avoir fait installer la victime en PLS, le chef d'agrès peut demander une équipe médicale pendant que le reste de l'équipe continue sa prise en charge.

7 **Surveiller attentivement et en permanence la respiration et la circulation de la victime :** la respiration de la victime doit être surveillée en continu si possible et au minimum toutes les minutes. Pour cela, le sapeur-pompier doit :

- **regarder le thorax et le haut de l'abdomen** de la victime se soulever ;

Contrôle de la respiration d'une victime en PLS



- **écouter d'éventuels sons** provoqués par la respiration ;
- **sentir le soulèvement du thorax** avec le plat de sa main.

Si l'état respiratoire de la victime s'aggrave :

- arrêt respiratoire ;
- fréquence inférieure ou égale à 6 mouvements par minute ; pause supérieure à 10 secondes.

Le sapeur-pompier doit alors replacer rapidement la victime sur le dos et pratiquer les gestes qui s'imposent (cf. chapitres 6 et 7).

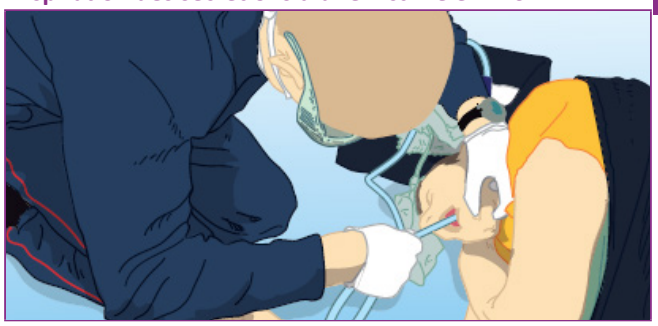
En l'absence du pouls radial, **le pouls carotidien doit être surveillé en permanence** afin de détecter un possible arrêt cardiaque.

La surveillance sera facilitée ultérieurement grâce a la pince du saturomètre et des alarmes du multiparamétrique.

8 **Désencombrer les voies aériennes :** si la victime présente des signes d'encombrement des voies aériennes : bruit de liquide au fond de la gorge (gargouillement), il faut réaliser une aspiration des sécrétions qui gênent la respiration (cf. fiche technique 18.1).

La mise en PLS de la victime doit s'effectuer en priorité, elle est ensuite complétée par l'aspiration des sécrétions si nécessaire.

Aspiration des sécrétions d'une victime en PLS



9 **Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries.**

Cas du sapeur-pompier isolé

Le sapeur-pompier isolé doit adapter cette conduite à tenir et en particulier réaliser :

- un retournement en urgence seul si nécessaire (cf. fiche technique 11.2) ;
- une mise en PLS à un sapeur-pompier (cf. fiche technique 17.2).

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

B.3 Le bilan primaire de la victime inconsciente qui respire avec notion de traumatisme

Chez toute victime inconsciente suspecte d'un traumatisme, tous les gestes de secours doivent être effectués en essayant de limiter l'aggravation d'une éventuelle lésion de la colonne cervicale.

Étape 1 : sauvegarde immédiate

L'approche de la victime ne diffère pas du principe général. Les circonstances et son apparence laissent à penser qu'elle est inconsciente et qu'elle semble victime d'un traumatisme. **Dans le doute,** ou lorsque les circonstances ne sont pas connues, **toute victime inconsciente est considérée comme traumatisée.**

1. **Maintenir immédiatement la tête de la victime** après une remise en position neutre si nécessaire (cf. fiche technique 16.1).

Étape 2 : conscience

1. **Apprécier la conscience :** la victime ne répond pas aux questions et ne réagit pas aux ordres simples, elle est inconsciente (coma).

Étape 3 : respiration ET Étape 4 : circulation simultanément

1. **Retourner systématiquement la victime** porteuse ou non d'un casque de protection **lorsqu'elle est allongée sur le ventre** (cf. fiches techniques 11.1 et 11.2). En équipe, le retournement s'effectue obligatoirement **à deux sapeurs-pompiers.**

2. **Retirer systématiquement le casque de protection.** Ce retrait est obligatoirement réalisé à deux lorsque les sapeurs-pompiers interviennent en équipe (cf. fiche technique 12.1) afin de limiter la mobilisation de la tête et de la nuque de la victime. S'il intervient seul, le sapeur-pompier doit également assurer ce retrait (cf. fiche technique 12.2).

Retrait du casque



3. **Libérer les voies aériennes :** dans ce cas, la bascule prudente de la tête en arrière est remplacée **par une élévation du menton seule** (cf. fiche technique 13.2) afin de ne pas entraîner une extension du cou pouvant aggraver une fracture du rachis cervical. Le reste de la libération des voies aériennes est inchangé.

4. **Apprécier la respiration et la circulation simultanément sur 10 secondes** (cf. fiche technique 14.1) et (cf. fiche technique 15.1).

Appréciation de la respiration chez une victime inconsciente suspectée de traumatisme



Pour cela un sapeur-pompier maintient la tête et élève le menton, le second apprécie la ventilation (cf. fiche technique 14.1).

Si le thorax ou le haut de l'abdomen se soulèvent, que d'éventuels bruits ou son souffle sont perçus, la victime respire.

Il ne faut pas confondre les gasps avec des mouvements respiratoires. En cas de gasps ou de respiration anormale, on considère la victime en arrêt respiratoire, donc en arrêt cardiaque.

En cas de pouls carotidien mal perçu ou douteux, on considère la victime en arrêt cardiaque. L'idée de demander à un équipier de vérifier le pouls carotidien doit faire conclure qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque.

Lorsqu'une respiration et une circulation efficaces sont détectées, la recherche doit s'interrompre immédiatement pour ne pas retarder la suite de la prise en charge.

Rechercher la présence du pouls radial pour détecter une détresse circulatoire en plus de la détresse neurologique.

5. **Placer un collier cervical systématiquement (cf. fiche technique 16.2).**

6. **Effectuer une palpation : cette palpation doit permettre d'apprécier les traumatismes évidents afin de déterminer le côté de la mise en PLS. Elle s'effectue de façon systématique de la tête aux pieds.**

7. **Si nécessaire placer la victime en PLS : la mise en PLS d'un blessé inconscient est réalisée systématiquement à 2 lorsque les sapeurs-pompiers interviennent en équipe (cf. fiche technique 17.1 et cf chapitre 15).**

Sinon assurer la LVA victime sur le dos (cf chapitre 15.9).

Mise en PLS d'une victime avec suspicion de traumatisme



Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

8. Administrer de l'oxygène par inhalation (cf. fiche technique 20.1).
9. Demander une équipe médicale.
10. Surveiller attentivement et en permanence la respiration et la circulation de la victime.
    - **regarder le thorax et le haut de l'abdomen** de la victime se soulever ;
    - **écouter d'éventuels sons** provoqués par la respiration ;
    - **sentir le soulèvement du thorax** avec le plat de sa main.

Si l'état respiratoire de la victime s'aggrave :

- arrêt respiratoire ;
- fréquence inférieure ou égale à 6 mouvements par minute ; pause supérieure à 10 secondes.

  Le sapeur-pompier doit alors replacer rapidement la victime sur le dos et pratiquer les gestes qui s'imposent (cf. chapitres 6 et 7).

En l'absence du pouls radial, **le pouls carotidien doit être surveillé en permanence** afin de détecter un possible arrêt cardiaque.

La surveillance sera facilitée ultérieurement grâce a la pince du saturomètre et des alarmes du multiparamétrique.

11. Désencombrer les voies aériennes si nécessaire (cf. fiche technique 18.1).
12. Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries.

Cas du sapeur-pompier isolé

Le sapeur-pompier isolé doit adapter cette conduite à tenir et en particulier réaliser :

- un retournement en urgence seul (cf. fiche technique 11.2) ;
- un retrait du casque seul (cf. fiche technique 12.2) ;
- la libération des voies aériennes qui se fera au moyen d'une élévation du menton seule et qui sera maintenue durant l'appréciation de la respiration ;
- À l'issue de cette appréciation, le maintien tête pourra être relâché pour la mise en PLS de la victime ;
- une mise en PLS à un sapeur-pompier (cf. fiche technique 17.2).

Remarque sur l'organisation de l'intervention :

Le démarrage de la RCP doit être le plus rapide possible.

En équipe, dans le cas d'une victime suspectée d'un traumatisme du rachis, le maintien tête peut être relâché si cela est indispensable à la réalisation des gestes de secours.

De même, la mise en place d'un collier cervical peut se faire postérieurement au démarrage de la RCP et ne doit en aucun cas la retarder (exemple : cas du pendu).

B.4 Le bilan primaire de la victime en arrêt respiratoire

La victime peut être soit en arrêt respiratoire, soit présenter des pauses respiratoires de plus de 10 secondes ou une fréquence respiratoire inférieure ou égale à 6 mouvements par minute ce qui est considéré comme un arrêt respiratoire.

Elle peut aussi présenter des gaps même supérieurs à 6 par minute.

Cet arrêt respiratoire est soit le signe d'un arrêt circulatoire, soit précurseur d'un arrêt circulatoire à très court terme.

4

Étape 1 : sauvegarde immédiate

L'approche de la victime ne diffère pas du cas général avec un maintien de la tête s'il existe une notion de traumatisme.

Dans le doute ou lorsque les circonstances ne sont pas connues, **toute victime inconsciente est considérée comme traumatisée**.

Étape 2 : conscience

1. **Apprécier la conscience :** la victime ne répond pas et ne réagit pas, elle est donc inconsciente (coma).

Étape 3 : respiration ET Étape 4 : circulation simultanément

1. **Retourner la victime lorsqu'elle est allongée sur le ventre** (cf. fiches techniques 11.1 et 11.2).
2. **Retirer systématiquement le casque de protection** (cf. fiche technique 12.1).
3. **Libérer les voies aériennes :** la libération des voies aériennes est identique à la conduite à tenir du bilan primaire de la victime inconsciente qui respire (cf. fiches techniques 13.1 et 13.2).
4. **Apprécier la respiration et circulation simultanément sur 10 secondes maximum,** (cf. fiche technique 14.1) :

   Il ne faut pas confondre les gasps avec des mouvements respiratoires. En cas de gasps ou de respiration anormale, on considère la victime en arrêt respiratoire, donc en arrêt cardiaque.

   En cas de pouls carotidien mal perçu ou douteux, on considère la victime en arrêt cardiaque. L'idée de demander à un équipier de vérifier le pouls carotidien doit faire conclure qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque.

   Après 10 secondes, **si le thorax** ou le haut de l'abdomen **ne se soulèvent pas, si aucun bruit ou souffle n'est perçu ou s'il y a des gasps, elle est en arrêt respiratoire.**
5. **En présence d'un pouls carotidien :**
   - **Débuter immédiatement une ventilation artificielle s'il s'agit d'une overdose aux opiacés** (cf. chapitre 6 partie 3).
   - sinon dans tous les cas **débuter immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire** (cf. chapitre 7 - partie 2).
6. Demander une équipe médicale.
7. **Demander un engin de prompt secours** (cas du VSAV).

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

Il est parfois difficile d'apprécier l'absence de respiration et cela peut nécessiter de prolonger la recherche sur 10 secondes supplémentaires

- **S'il n'existe aucune respiration sur 10 secondes,** alors il s'agit d'un arrêt respiratoire ;
- **S'il existe deux respirations ou plus sur 10 secondes,** alors la FR est strictement supérieure à 6 et ce n'est pas un arrêt respiratoire.

N. B. :

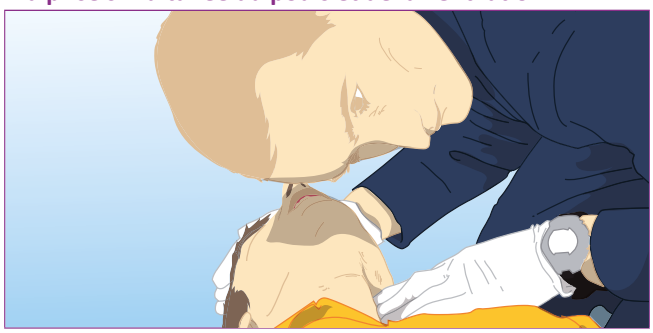
S'il n'y a que deux respirations en 10 secondes, alors la surveillance doit être constante, car c'est une situation susceptible d'évoluer vers l'arrêt de la respiration)

- **S'il n'existe qu'une respiration sur 10 secondes,** il faut alors compter au bout de combien de secondes la respiration suivante apparait :
  - S'il n'y a pas de respiration au bout de ces 10 secondes supplémentaires, alors la FR est < ou égale à 6/min et c'est un arrêt respiratoire (pause d'au moins 10 secondes entre deux respirations) ;
  - S'il y a une respiration avant ces 10 secondes supplémentaires, alors la FR est strictement > 6/min et ce n'est pas un arrêt respiratoire.

N. B. :

La surveillance doit être constante, car c'est une situation susceptible d'évoluer vers l'arrêt de la respiration

La prise simultanée du pouls et de la ventilation



Cas du sapeur-pompier isolé

Le sapeur-pompier isolé doit adapter cette conduite à tenir et en particulier réaliser :

- un retournement en urgence seul si nécessaire (cf. fiche technique 11.2) ;
- un retrait du casque seul (cf. fiche technique 12.2) ;
- **une alerte immédiate dès la découverte du seul arrêt respiratoire** sauf dans les **cas particuliers du noyé de l'enfant, du nourrisson et du nouveau-né pour lesquels 10 insufflations sont pratiquées au préalable**.

B.5 Le bilan primaire de la victime en arrêt cardiaque (sauf le nouveau-né à la naissance)

La victime est en arrêt cardiaque dès lors qu'elle ne présente pas de pouls certain sur une durée de 10 secondes au plus ou qu'elle est en arrêt respiratoire (sauf overdose), ou qu'elle pressente des gasps.

Étape 1 : sauvegarde immédiate

L'approche de la victime ne diffère pas du cas général. Il faut effectuer un maintien de la tête s'il existe une notion de traumatisme. **Dans le doute** ou lorsque les circonstances ne sont pas connues, **toute victime inconsciente est considérée comme traumatisée.**

Étape 2 : conscience

1. **Apprécier la conscience :** la victime ne répond pas et ne réagit pas, **elle est donc inconsciente (coma)**.

Étape 3 : respiration ET Étape 4 : circulation simultanément

1. **Retourner la victime lorsqu'elle est allongée sur le ventre** (cf. fiches techniques 11.1 et 11.2).
2. **Retirer systématiquement le casque de protection** (cf. fiche technique 12.1).
3. **Libérer des voies aériennes** (cf. fiches techniques 13.1 et 13.2).
4. **Apprécier la respiration et circulation simultanément sur 10 secondes maximum,** (cf. fiche technique 14.1) et (cf. fiche technique 15.1) :

   Il ne faut pas confondre les gasps avec des mouvements respiratoires. En cas de gasps ou de respiration anormale, on considère la victime en arrêt respiratoire, donc en arrêt cardiaque.

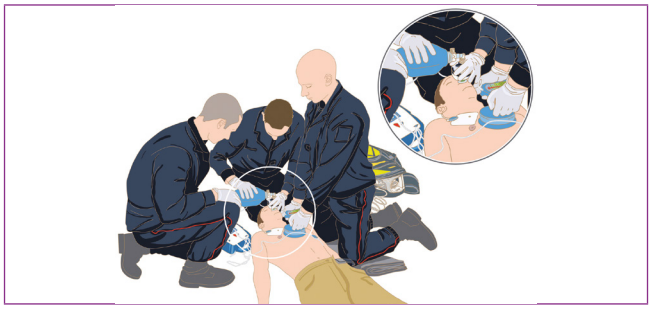
   En cas de pouls carotidien mal perçu ou douteux, on considère la victime en arrêt cardiaque. L'idée de demander à un équipier de vérifier le pouls carotidien doit faire conclure qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque.

   Après 10 secondes, **si le thorax** ou le haut de l'abdomen **ne se soulèvent pas, si aucun bruit ou souffle n'est perçu, elle est en arrêt respiratoire.**

   Si après 10 secondes, **aucun pouls certain n'est perçu, la victime est en arrêt cardiaque.**

5. **Débuter immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire** (cf. chapitre 7 - partie 2).

Vue d'ensemble sur une manœuvre de RCP



6. **Demander une équipe médicale.**
7. **Demander un engin de prompt secours** (cas du VSAV).

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

Cas du sapeur-pompier isolé

Le sapeur-pompier isolé doit adapter cette conduite à tenir et en particulier réaliser :

- un retournement en urgence seul si nécessaire (cf. fiche technique 11.2) ;
- un retrait du casque seul (cf. fiche technique 12.2) ;
- **une alerte immédiate dès la découverte de l'arrêt cardiaque** sauf dans les **cas particuliers du noyé de l'enfant, du nourrisson et du nouveau-né pour lesquels 5 insufflations et 5 cycles de RCP seront pratiqués au préalable.**



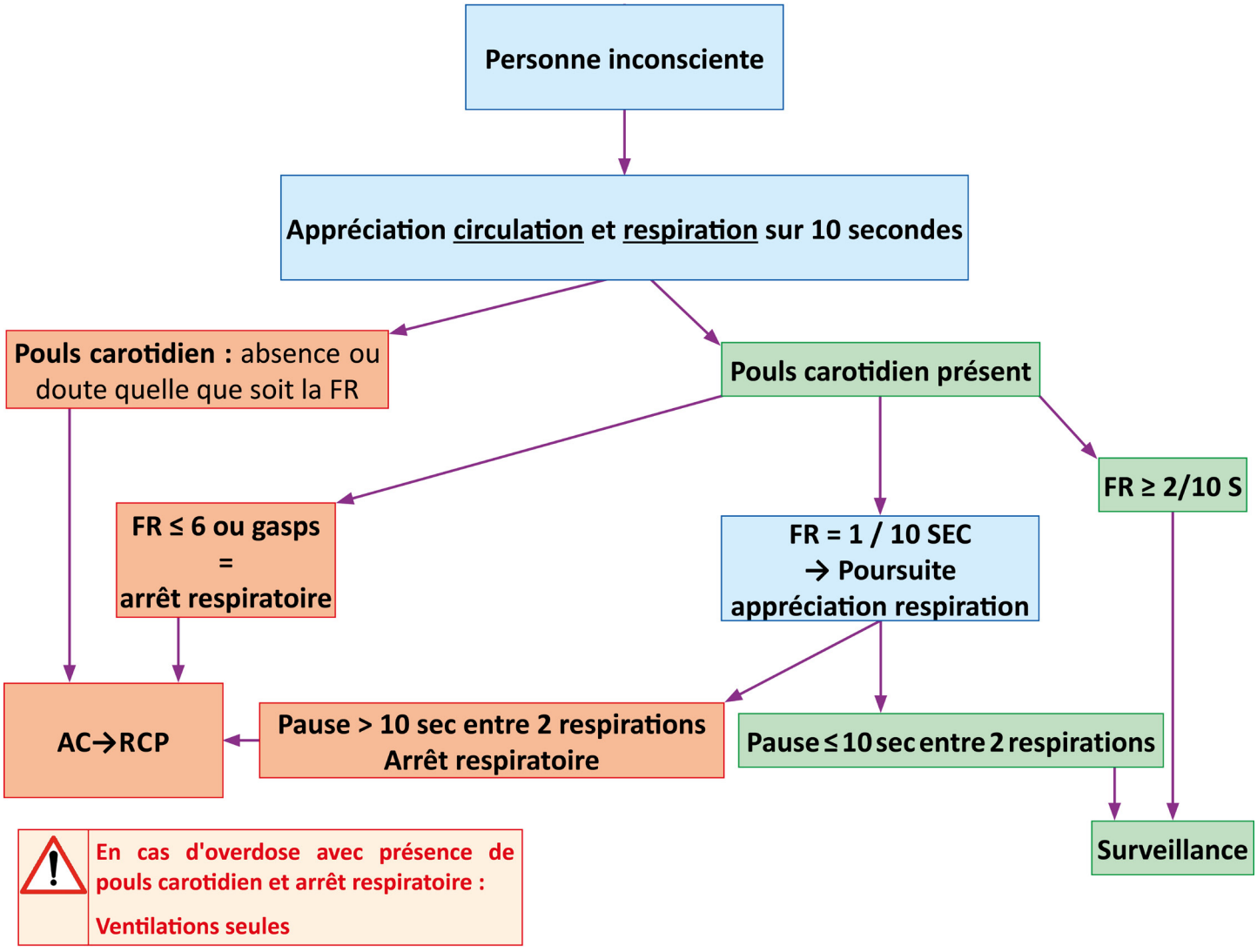
Bilan primaire d'une personne présentant une détresse vitale

Lors de la phase de réalisation des gestes de sauvegarde immédiatement après les 10 à 20 secondes de bilan primaire, **le facteur temps est capital.** C'est pourquoi :

Le CA doit anticiper ces actions et l'utilisation des matériels (ballon insufflateur, garrot, oxygène…). L'ODE indique déjà une certaine criticité de l'intervention : personne inconsciente, détresse respiratoire, hémorragie…

Par exemple, arrivé auprès d'une personne inconsciente, présentant une immobilité complète ou une respiration anormale, le CA doit commander avant même de toucher la personne pour le bilan primaire le DSA, le ballon insufflateur, afin d'être prêt pour débuter la procédure.

Bilan primaire d'une victime inconsciente



Bilan primaire d'une victime inconsciente :

RESPIRATION	oui	non contexte overdose	non autres situations	oui	non
CIRCULATION	oui	oui	oui	non	non
ÉTAT	inconscience	arrêt respiratoire	arrêt cardiaque	arrêt cardiaque	arrêt cardiaque
CONDUITE À TENIR	PLS ou sur le dos avec LVA	insufflations +/- CAT spécifique	RCP	RCP	RCP

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

Bilan primaire

- **Sauvegarde immédiate :**
  - apparence de la victime et contexte dans lequel elle se trouve
  - notion de traumatisme
  - position de la victime
  - âge et sexe
  - existence d'une détresse vitale évidente : LVA et arrêt des hémorragies
- **Conscience :**
  - conscience ou coma
  - identification de la plainte principale
- **Respiration :**
  - respiration ou arrêt respiratoire ou arrêt cardiaque
  - signes évidents de détresse respiratoire
- **Circulation :**
  - circulation ou arrêt cardiaque
  - signes de détresse circulatoire
- **Positions d'attente et O_2**

Notion sur la détresse

Demande d'équipe médicale en urgence

Tableaux des positions d'attente de la victime qui respire et qui a une circulation

Détresse	Position	Adaptation
Inconscience	PLS	Sauf si PLS dangereuse
Inconscience et femme enceinte	PLS quel que soit le côté	
Détresse respiratoire	Assis	
Détresse respiratoire et obèse	Assis à 45°	
Détresse respiratoire et femme enceinte 3e trimestre	Assis à 45°	
Détresse circulatoire	Allongé	+/- surélévation des membres inférieurs si PAS < 90 mm Hg
Détresse circulatoire et inconscience	PLS	
Détresse respiratoire et détresse circulatoire	Assis à 45° et membres inférieurs allongés	
Détresse respiratoire de type œdème aigu du poumon sans détresse circulatoire	Assis ou assis 45° et membres inférieurs plus bas que le corps (= jambes pendantes, pieds au sol ou à distance du sol selon l'installation)	

Chez la femme enceinte et la personne obèse, l'encombrement abdominal gêne les mouvements d'abaissement du diaphragme et limitent l'inspiration. La position assise inclinée à 45° environ facilite alors la respiration.